

Arritmias, Síncope e PCR no Adulto

Vamos começar com uma situação bem prática: você está no pronto-socorro e chega um paciente com taquicardia. O eletrocardiograma mostra frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, QRS estreito, ritmo regular e sem onda P. Seu residente pergunta qual o diagnóstico. Ao final desta explicação, você vai saber responder isso tranquilamente.

Diagnóstico das Taquiarritmias

Quando você se depara com uma taquiarritmia no eletrocardiograma, precisa fazer algumas perguntas essenciais. Essas perguntas funcionam como um checklist que vai te guiar até o diagnóstico correto. Primeiro, confirme que realmente é uma taquicardia verificando se a **frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto**. Depois, observe se o **complexo QRS é estreito** (menor que 120 ms) ou **largo** (maior que 120 ms). Em seguida, procure pela presença de **onda P**. Avalie se o **ritmo é regular** e verifique se existem **ondas F** (maiores) ou **ondas f** (menores). Respondendo essas perguntas em sequência, você consegue encaixar o paciente em determinada arritmia com bastante precisão.

Taquicardia Sinusal

A taquicardia sinusal é caracterizada por frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto com **onda P positiva em D1, D2 e aVF, negativa em aVR**, e toda onda P precedendo um complexo QRS. O ritmo é regular e não há presença de ondas F. As causas mais comuns incluem **tireotoxicose, febre, hipovolemia e anemia**. O ponto fundamental aqui é que a taquicardia sinusal é uma resposta fisiológica a alguma condição de base, não uma arritmia propriamente dita que precisa ser tratada com medicações antiarrítmicas.

Taquicardia por Reentrada Nodal

Este é um tipo de **taquicardia supraventricular**, ou seja, origina-se acima do nó atrioventricular. Na prática e nas provas, quando você vê o termo "taquicardia supraventricular" ou "taqui supra", geralmente estão se referindo à reentrada nodal, embora tecnicamente sejam conceitos um pouco diferentes. As características no eletrocardiograma são: frequência cardíaca maior que 100, **ausência de onda P**, ritmo regular e **QRS estreito** (até 120 ms). Nas questões de prova, costumam descrever **mulheres jovens**, que é realmente o perfil epidemiológico mais comum. O que diferencia esta arritmia da taquicardia sinusal é justamente a ausência da onda P, enquanto na sinusal você identifica claramente aquela onda P com as características específicas que descrevemos.

Fibrilação Atrial

A fibrilação atrial também é um tipo de taquicardia supraventricular. Os critérios diagnósticos são: frequência maior que 100 batimentos, ausência de onda P, **ritmo irregular** (isso é fundamental para diferenciar das outras arritmias) e QRS estreito. A característica marcante é a presença das **ondas f** (minúsculas), que aparecem como um tremor ou serrilhado da linha de base ao longo de todo o traçado eletrocardiográfico. Esse tremular costuma ser mais evidente na derivação V1, mas isso não é uma regra absoluta. Esse padrão de linha de base tremulada é o que caracteriza a fibrilação atrial.

Flutter Atrial

O flutter atrial compartilha várias características com a fibrilação: é uma arritmia supraventricular, tem frequência cardíaca maior que 100, ausência de onda P e QRS estreito. A diferença começa no ritmo, que pode ser **regular ou irregular**, dependendo da condução atrioventricular. A característica mais marcante é a presença das **ondas F maiúsculas** com padrão de "**barbatana de tubarão**", visíveis em várias derivações, especialmente D2, D3, AVF e no D2 longo. A frequência

cardíaca no flutter costuma girar em torno de **150 batimentos por minuto** de forma bastante consistente, tanto que chamamos o flutter de "arritmia matemática".

Comentário crítico: O flutter pode ter condução variável, o que explica por que às vezes o ritmo é regular e outras vezes irregular. Quando temos um padrão de "três para um" (três ondas F para cada QRS), o intervalo RR permanece constante. Mas quando a condução é variável, alternando entre três, quatro ou cinco ondas F por QRS, o intervalo RR se torna irregular. Esse conceito não é muito cobrado em provas, mas ajuda a entender a fisiopatologia.

Taquicardia Ventricular

Agora entramos nas taquicardias de complexo QRS largo. A taquicardia ventricular pode ser **monomórfica** ou **polimórfica**. Na forma monomórfica, o QRS mantém a mesma morfologia ao longo de todo o traçado nas várias derivações. Já na polimórfica, dentro da mesma derivação você observa complexos QRS com várias morfologias diferentes. As características da forma monomórfica são: ausência de onda P, ritmo regular, **QRS largo** (primeira arritmia que estamos falando com QRS maior que 120 ms) e QRS com morfologia uniforme.

A forma polimórfica, também conhecida pelo nome clássico de **Torsades de Pointes**, apresenta ausência de onda P, ritmo irregular, QRS largo e morfologias diferentes dos complexos. No traçado você observa uma verdadeira anarquia: ora um QRS grande, ora pequeno, um apontando para cima, outro para baixo. Esse polimorfismo caótico caracteriza a torsades de pointes.

A torsades de pointes geralmente está relacionada ao **prolongamento do intervalo QT**. Pode ser congênito ou adquirido, frequentemente associado a **hipocalemia** ou **hipomagnesemia**. Várias medicações podem prolongar o QT, incluindo **amiodarona, azitromicina, levofloxacina, sotalol, propafenona, haloperidol, risperidona, amitriptilina e hidroxycloquina**.

Fibrilação Ventricular

Este é um **ritmo de parada cardiorrespiratória**. Um conceito absolutamente fundamental: **a fibrilação ventricular não gera pulso**. Não adianta você ver uma fibrilação ventricular no monitor e tentar palpar o pulso do paciente - ele não terá pulso. Isso é uma dica prática importante que aparece em provas. Como é um ritmo de parada, você deve seguir o **fluxograma do ACLS** imediatamente. O traçado é definido como um ritmo anárquico incapaz de gerar batimento cardíaco efetivo. O complexo QRS nem chega a se formar; você vê apenas tremulações grosseiras da linha de base. Esse é o padrão eletrocardiográfico da fibrilação ventricular.

Tratamento das Taquiarritmias

Agora vem o slide mais importante de toda a aula. Pare o que está fazendo e grave os **sinais de instabilidade** de uma taquiarritmia, porque se o paciente apresentar qualquer um desses sinais, a conduta é **cardioversão elétrica sincronizada** e pronto.

Os sinais de instabilidade são:

- **Dor torácica anginosa** (destaco "anginosa" porque às vezes a questão coloca apenas desconforto torácico, que não conta como critério; uma frequência de 180 naturalmente causa desconforto, mas para ser critério de instabilidade tem que ser dor anginosa verdadeira)
- **Sinais de insuficiência cardíaca aguda**
- **Rebaixamento do nível de consciência**
- **Hipotensão arterial**

Identificou qualquer um desses quatro sinais? A conduta é cardioversão elétrica sincronizada imediatamente.

Tratamento da Taquicardia Sinusal

O tratamento da taquicardia sinusal consiste em **identificar e tratar a causa base**. Nas provas, se você vê taquicardia sinusal e alternativas oferecendo condutas

antiarrítmicas como betabloqueador ou cardioversão elétrica, não vá por esse caminho. A abordagem correta é tratar a causa: febre necessita antitérmico, hipovolemia necessita reposição volêmica, hipertireoidismo necessita drogas antitireoidianas. Não se faz tratamento para a arritmia em si.

Tratamento da Taquicardia por Reentrada Nodal

Se o paciente apresentar sinais de instabilidade, faça cardioversão sincronizada. Esta arritmia responde com baixa energia, podendo-se iniciar com **50 joules**. Se não resolver, pode-se aumentar a energia. Se o paciente está estável hemodinamicamente, o primeiro passo é a **manobra vagal**, especificamente a **manobra de Valsalva modificada**. Você explica ao paciente para soprar uma seringa por 15 segundos tentando empurrar o êmbolo. Quando completar esse tempo, deite o paciente subitamente. É importante explicar que haverá uma sensação de desconforto, mantendo monitorização contínua para verificar se a arritmia se reverte.

Se a manobra vagal não funcionar, o segundo passo é administrar **adenosina**. A dose inicial é **6 mg endovenoso**; se não houver resposta, administre **12 mg** (uma ampola tem 6 mg). Um detalhe crucial: a adenosina tem meia-vida fugaz, então é essencial fazer **flush de soro rapidamente e elevar o membro** após a administração. A adenosina é **contraindicada em broncoespasmo ativo**. Se houver cateter venoso central, use **metade da dose** (3 mg).

Tratamento da Fibrilação Atrial

Se houver sinais de instabilidade, cardioversão elétrica sincronizada está indicada. Depois surgem duas perguntas fundamentais no manejo da fibrilação atrial: vou fazer **controle de ritmo ou controle de frequência**? E devo **anticoagular** ou não?

Controle de ritmo versus controle de frequência: Esta não é uma decisão arbitrária. Alguns critérios ajudam a escolher a melhor estratégia. O controle de ritmo faz mais sentido em pacientes **jovens, no primeiro evento de fibrilação atrial, sintomáticos e com átrio esquerdo menor que 50 mm**. Esse paciente tem alta chance de retornar

ao ritmo sinusal e mantê-lo. Por outro lado, em pacientes **idosos, com fibrilação atrial recorrente, assintomáticos e com átrio esquerdo maior que 50 mm**, a chance de recorrência após reversão é muito alta, então às vezes o controle de frequência é mais apropriado.

Estratégias farmacológicas para controle de ritmo: Se há **cardiopatía estrutural** (hipertrofia ou alteração valvar), use **amiodarona**. Se não há cardiopatía estrutural, pode-se usar **sotalol ou propafenona**. A opção não farmacológica é a **ablação**, muito indicada em pacientes com insuficiência cardíaca.

Uma estratégia específica às vezes cobrada em provas é o **"pill in the pocket"** com propafenona. É indicada em fibrilação atrial paroxística, com poucos episódios, sintomática e sem cardiopatía estrutural. O paciente toma a medicação em casa quando começa a sentir a arritmia.

Controle de frequência: O alvo é reduzir a frequência para cerca de **110 batimentos por minuto**. Se o paciente está com 180, não precisa trazer para 80; o objetivo é em torno de 110 batimentos. As opções incluem: **betabloqueador, bloqueadores de canal de cálcio** (diltiazem ou verapamil), **digoxina** ou **amiodarona**. Vale lembrar que a amiodarona pode acabar revertendo o ritmo, mas também pode ser usada para controle de frequência.

Mnemônico para efeitos colaterais da amiodarona - "TRETA NERVOSA":

- Tireoidopatia
- Retinopatia
- ECG com prolongamento do QT
- Tórax (pneumonite)
- Abdome (hepatite medicamentosa)
- Neuropatia periférica

Anticoagulação: Use o escore **CHA₂DS₂-VA** (antigamente CHA₂DS₂-VASc, mas sexo feminino deixou de pontuar). Se a pontuação for **maior ou igual a 2, anticoagular**. Situações que indicam anticoagulação independente do escore: **cardiomiopatia**

hipertrófica, amiloidose, hipertireoidismo descompensado e miocárdio não compactado.

Qual anticoagulante usar?

- **Fibrilação atrial não valvar:** DOACs (anticoagulantes orais diretos)
- **Fibrilação atrial valvar** (estenose mitral moderada a importante ou prótese metálica em qualquer válvula): **varfarina**
- **FA + síndrome antifosfolípide:** varfarina
- **FA + doença renal crônica dialítica:** varfarina ou apixabana

DOACs disponíveis:

Inibidores do fator Xa (têm "xa" no nome):

- **Rivaroxabana:** 20 mg/dia (se clearance 30-50, ajustar dose; se <30, não utilizar)
- **Apixabana:** 5 mg 12/12h ou 2,5 mg 12/12h se dois dos seguintes critérios: creatinina $\geq 1,5$; idade >80 anos; peso <60 kg

Inibidor direto da trombina:

- **Dabigatrana** (dabiga"TR"ana inibe "TR"ombina): primeira opção em AVC cardioembólico

Fibrilação atrial na emergência: Se instável, cardioversão elétrica sincronizada com **100 joules**. Se estável, avalie o tempo de início dos sintomas. Com **menos de 24 horas** de início (mudança recente de 2025, antes eram 48 horas), pode fazer controle de ritmo diretamente. Com **mais de 24 horas**, realizar ecocardiograma transesofágico. Se não houver trombo no eco, pode fazer controle de ritmo; se houver trombo ou se não tiver eco disponível, fazer **anticoagulação por 3 a 4 semanas**, controlar frequência e depois retornar para controle de ritmo.

Pegadinha importante: Mesmo após reverter o ritmo, **mantenha o paciente anticoagulado por pelo menos 4 semanas** ou para o resto da vida se CHA_2DS_2-VA for maior que 2.

Tratamento do Flutter Atrial

O tratamento do flutter é **igual ao da fibrilação atrial**. A cardioversão elétrica responde com **50 joules**, sendo uma arritmia que responde de forma mais tranquila.

Tratamento da Taquicardia Ventricular

Se houver critérios de instabilidade, cardioversão sincronizada. Se o paciente está estável, pode-se fazer **amiodarona 300 mg em ataque**, seguida de **900 mg em 24 horas** como manutenção. Se não reverter com o ataque, pode-se fazer cardioversão elétrica mesmo sem sinais de instabilidade. Lembre-se que taquicardia ventricular é também um ritmo de parada - se o paciente não tiver pulso, siga o fluxograma do ACLS.

Tratamento da Taquicardia Ventricular Polimórfica (Torsades de Pointes)

Esta arritmia geralmente cursa com instabilidade, inclusive sendo um ritmo de parada. O tratamento agudo é a **desfibrilação** (não cardioversão sincronizada). Por que desfibrilação e não cardioversão? Na cardioversão sincronizada, o aparelho sincroniza com cada complexo QRS. Na taquicardia ventricular polimórfica há tanta anarquia dos complexos que o aparelho não consegue sincronizar. Por isso, o tratamento é a desfibrilação não sincronizada.

Esta síndrome geralmente está relacionada ao **QT longo**, podendo ser congênito ou adquirido, frequentemente associado a **hipocalemia** ou **hipomagnesemia**. Se o paciente está estável, administre **sulfato de magnésio 2 gramas em bolus**.

Bradiarritmias

Agora vamos falar sobre as bradiarritmias, definidas por **frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto**.

Bradicardia Sinusal

É o ritmo sinusal com frequência menor que 50. Mantém **onda P positiva em D1, D2 e aVF**, negativa em aVR, e toda onda P precedendo um QRS. As causas podem ser fisiológicas (atletas ou durante o sono) ou patológicas: **doença do nó sinusal, infarto inferior** (a coronária direita irriga o nó sinusal, causando o chamado **reflexo de Bezold-Jarisch**), **hipotireoidismo** e medicações (**betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, digitálicos e amiodarona**).

Pausa Sinusal

Mantém o ritmo sinusal com onda P positiva em D1, D2 e aVF. O que acontece é o chamado **silêncio sinusal**: você tem batimentos sinusais normais, mas ao invés de vir o próximo batimento em seguida, entra uma pausa. Quando a pausa termina, o batimento que se segue também é sinusal. Pausas **maiores que 3 segundos** costumam trazer sintomas. Pode ocorrer durante o sono, em atletas, na doença do nó sinusal ou na síndrome de apneia e hipopneia do sono.

Bloqueios Atrioventriculares

Nos bloqueios atrioventriculares, o problema não é a geração do estímulo, mas a **condução**. O nó sinusal gera o batimento normalmente, mas ele não chega adequadamente no ventrículo, gerando bradiarritmia.

Bloqueio AV de primeiro grau: Não há bloqueio verdadeiro, apenas um atraso na condução. É definido por **intervalo PR maior que 200 ms** (5 quadradinhos pequenos). Em geral não leva a sintomas. A analogia clássica: é aquele aluno que chega atrasado todo dia, mas sempre chega na aula.

Bloqueio AV de segundo grau: Aqui sim há bloqueio verdadeiro - algumas ondas P não serão conduzidas ao ventrículo. Classificamos em **Mobitz I** ou **Mobitz II**.

O **Mobitz I** apresenta o **fenômeno de Wenckebach**: prolongamento progressivo do intervalo PR até bloquear e a onda P não conduzir. O intervalo PR antes e após a onda P bloqueada é progressivamente maior. A analogia: aquele aluno que hoje atrasou, amanhã atrasa um pouco mais, depois de amanhã atrasa mais ainda e no quarto dia ele falta. Em geral é benigno.

O **Mobitz II** apresenta **ondas P que bloqueiam subitamente**, sem o fenômeno de Wenckebach. **O intervalo PR pode ser até normal**. A analogia: aquele aluno que chega no horário, traz até um presente, você acha que é um bom aluno, e no terceiro dia ele falta do nada sem avisar. O Mobitz II é **sempre patológico** - tem causas como doença isquêmica, doença de Chagas, distúrbio hidroeletrólítico, cardiopatia estrutural ou doença degenerativa.

Bloqueio AV de terceiro grau (BAVT): Há **dissociação total** entre átrio e ventrículo. Eles batem completamente independentes. Como identificar? O **intervalo PP é regular** (átrio gerando estímulo normalmente) e o **intervalo RR também é regular** (ventrículo conduzindo por conta própria), mas **não há associação** entre ondas P e complexos QRS. Às vezes a onda P pode cair dentro de um QRS ou de uma onda T, deformando-os um pouco.

Pegadinha: As ondas P podem cair no meio dos complexos, então fique atento. Calcule os intervalos PP e RR - se ambos forem regulares mas sem associação entre P e QRS, muito provavelmente é BAVT.

As causas podem ser congênitas ou adquiridas (isquemia, cardiopatia estrutural, complicação pós-operatória, distúrbios hidroeletrólíticos ou degeneração do nó AV). O tratamento é o **marca-passo definitivo**. Existe uma situação específica: se houver BAVT pós-infarto, pode-se **esperar 14 dias** antes de indicar o marca-passo definitivo, pois pode ser reversível.

Tratamento das Bradiarritmias

Primeiro passo: avaliar a instabilidade. Os sinais de instabilidade são os mesmos das taquiarritmias: **hipotensão, dor anginosa, sintomas de insuficiência cardíaca, síncope ou sinais de choque**. Se presente, administre **atropina 1 mg endovenoso**, podendo repetir até **três vezes a cada 3 a 5 minutos**. Se não resolver, inicie **adrenalina em bomba** (2 a 10 mcg/kg/min), **dopamina em bomba** (5 a 10 mcg/kg/min) ou **marca-passo transcutâneo temporário** (não há superioridade entre essas opções, fica a critério).

Após tirar o paciente da instabilidade, programe um **marca-passo transvenoso** com calma.

Síncope

Síncope é definida como **perda súbita da consciência e do tônus**, não traumática, com **recuperação rápida e completa** da consciência. Divide-se em três grupos: **neuromediada, ortostática e cardiogênica**.

Síncope Neuromediada

Pode ser **ortostática** (aquela pessoa que fica muito tempo na fila em pé debaixo do sol quente e apaga, ou em ambientes muito cheios como metrô e ônibus), **emocional** (crise de dor, pânico ou ansiedade seguida de síncope) ou **situacional** (exemplo clássico: paciente com hiperplasia prostática benigna que faz força para urinar e depois tem síncope).

O tratamento consiste em **educar o paciente, usar meias elásticas e aumentar a ingestão de sal e água**. Em casos refratários, pode-se usar **fludrocortisona**.

Síncope Ortostática

Não confunda com a síncope ortostática neuromediada. Aqui é relacionado à **hipotensão postural** verdadeira, definida por queda da pressão arterial **maior ou igual a 20 mmHg na sistólica ou 10 mmHg na diastólica** ao mudar de posição. Os principais desencadeantes são: exercício físico, pós-prandial, neuropatia periférica (muito comum no diabetes) e **medicamentosa** (principalmente diuréticos, com destaque para **hidroclorotiazida**, que é muito cobrada em provas).

O tratamento inclui **avaliar e corrigir desencadeantes**, aumentar ingestão de água e sal (1,5 a 3 litros de água por dia), meias elásticas e, em casos refratários, **fludrocortisona ou midodrina**.

Síncope Cardiogênica

Esta é a síncope perigosa que precisa ser investigada. Grave os critérios que fazem você pensar em síncope cardiogênica:

- **Síncope sem pródromos durante exercício físico ou na posição supina**
- Paciente que estava deitado ou sentado e teve síncope
- **Precedida por palpitação, dor torácica ou dispneia**
- **Síncope associadas a TCE** (trauma cranioencefálico)

Viu algum desses critérios? Pense em síncope cardiogênica e investigue com **ecocardiograma transtorácico, Holter de 24 horas, estudo eletrofisiológico ou cateterismo**. O tratamento depende da causa base encontrada.

Parada Cardiorrespiratória (PCR) - ACLS

O ACLS é o fluxograma seguido quando o paciente tem parada cardiorrespiratória. Vamos focar nos pontos mais importantes.

Ritmos de PCR:

- **Chocáveis:** taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular
- **Não chocáveis:** AESP (atividade elétrica sem pulso, que é qualquer ritmo organizado sem pulso) e assistolia

AESP: Qualquer ritmo organizado sem pulso - pode ser fibrilação atrial, flutter, sinusal, não precisa ser necessariamente sinusal. Sempre que houver ritmos não chocáveis, procure os **5H e 5T**:

5H: Hipovolemia, Hipotermia, Hipoxemia, **H+** (acidose), Hiper/hipocalemia

5T: Tamponamento cardíaco, Tensão no tórax (pneumotórax), Trombose coronariana, TEP (trombose pulmonar), Toxinas

Assistolia: Antes de confirmar, faça o protocolo **CAGADA**: **C**hecar cabos, **A**justar **G**anhos e verificar **D**erivação. Checou tudo e realmente é assistolia? Siga o tratamento.

Suporte Básico de Vida (BLS)

Sequência fundamental (grave essa ordem):

1. **Checar segurança da cena** (não é checar pulso primeiro!)
2. Avaliar responsividade
3. Chamar ajuda
4. Acionar serviço de emergência
5. Providenciar o DEA (desfibrilador externo automático)
6. **Só então checar pulso e respiração** (no máximo 10 segundos)

Sem pulso e sem respiração: iniciar compressões **30 para 2** até garantir via aérea. Quando garantir via aérea, **uma ventilação a cada 6 segundos**. Assim que disponível, **usar o DEA** (parar tudo e desfibrilar se indicado).

Compressões de Qualidade

As medidas com mais evidência no ACLS são **RCP de qualidade e desfibrilação precoce**. Compressão de qualidade significa:

- Frequência: **100 a 120 compressões por minuto**
- Profundidade: **5 a 6 cm**
- Permitir retorno completo do tórax
- Minimizar interrupções
- **Não interromper por mais de 10 segundos**
- **Trocar o massageador a cada 2 minutos**
- Sem via aérea garantida: **30 compressões para 2 ventilações**

ACLS Avançado

Chegou o ACLS: "**tubo e veia**".

Medicações que podem ser feitas pelo tubo (sigla **VANEL**): **V**asopressina, **A**tropina, **N**aloxone, **E**pinefrina, **L**idocaína. Mas só faça isso se for a última opção - **acesso preferencial é endovenoso ou intraósseo**.

Adrenalina

- Nos ritmos não chocáveis, administre imediatamente após constatação do ritmo
- Nos ritmos chocáveis, administre após o **segundo choque**.
- Em ambos os cenários, continue administração de adrenalina 1mg a cada 3 a 5 min

Amiodarona (somente em ritmos chocáveis):

- Primeira dose: **300 mg após o terceiro choque**
- Segunda dose: **150 mg após o quinto choque** (metade da primeira dose)
- Não faça mais após a segunda dose

Alternativa à amiodarona - Lidocaína:

- Primeira dose: **1 a 1,5 mg/kg**
- Segunda dose: **metade da primeira dose**, 5 a 10 minutos depois

Monitorização da Qualidade das RCPs

Pressão arterial invasiva: Se disponível, pressão diastólica **maior que 20 mmHg** indica compressões adequadas.

Capnografia (ETCO₂):

- **ETCO₂ >10:** compressões de qualidade
- **ETCO₂ sobe subitamente para >30:** suspeitar de retorno à circulação espontânea
- **ETCO₂ <10 persistentemente por 20 minutos:** considerar interromper esforços

Causas Reversíveis (5H e 5T) - Tratamento

5H:

- **Hipovolemia** → reposição volêmica
- **Hiper/hipocalemia** → gluconato de cálcio ou reposição de potássio
- **Acidose** → bicarbonato
- **Hipotermia** → aquecimento
- **Hipóxia** → ventilação adequada ou via aérea avançada

5T:

- **Trombose coronariana** → considerar trombólise intra-parada (baixa evidência)
- **TEP** → trombólise **50 mg em 10 minutos**, depois reanimar por **50 minutos**
- **Tamponamento cardíaco** → pericardiocentese
- **Tensão no tórax** (pneumotórax) → toracocentese

- **Toxinas** → tratamento específico

Cuidados Pós-PCR

Metas:

- Saturação: **92-98%**
- PaCO₂: **40-45 mmHg** (normocapnia)
- PAS **>90 mmHg** ou PAM **≥65 mmHg**
- Glicemia: **140-180 mg/dL**
- **Controle de temperatura**: manter entre **32-36°C** por pelo menos **24 horas**
- Monitorar e tratar crises epiléticas

Resumo dos Gatilhos Essenciais

1. **Sinais de instabilidade** (dor torácica anginosa, sinais de IC, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência) → **Cardioversão elétrica sincronizada imediata**
2. **Fibrilação atrial na emergência**: O tempo de início dos sintomas mudou para **24 horas em 2025** (antes eram 48h). Mesmo após reverter o ritmo, **manter anticoagulado por 4 semanas**.
3. **Síncope cardiogênica**: **SEM pródromos** durante exercício físico ou posição supina, precedida por palpitação, dor torácica ou dispneia, ou associada a TCE → investigar!

Espero que esse material ajude vocês a dominarem esse tema tão importante. Bons estudos e sucesso nas provas!